

Un genitore autistico nel vostro ambulatorio

Per medici di famiglia, ostetriche e consultori — nella cura di un adulto autistico che è (o sta per diventare) genitore.

L'idea chiave

L'autismo, attraverso il **monotropismo**, significa che l'attenzione di un genitore si blocca in pochi „tunnel” profondi e intensi. Il genitorialità è implacabile, ad alto canale e imprevedibile — esattamente le condizioni che un sistema monotropico trova più difficili. Molti genitori autistici sono **assistenti eccellenti e profondamente attenti** nei loro interessi e ritmi, ma portano un **alto rischio di burnout** e spesso ignorano i propri bisogni di salute perché, quando sono assorbiti dal bambino, i segnali interni (fame, dolore, esaurimento) non si registrano. Sono spesso non diagnosticati finché la valutazione di un bambino non rende visibili i loro tratti.

Cosa potreste vedere — e cosa sta davvero accadendo

Potreste vedere...	Cosa spesso sta accadendo
Esausto/a, sovraccarico/a sensorialmente, „non ce la fa”, eppure devoto/a	Carico genitoriale su un sistema monotropico — alto rischio di burnout, non cattiva genitorialità
Salta i propri appuntamenti, ignora il proprio dolore/malattia	Differenze di interocezione + iper-focus sul bambino
Ansia perinatale, sovraccarico, shutdown	Prevedibile sotto l'imprevedibilità di un neonato — non „non si lega”
Diagnosticato/a solo dopo il proprio bambino	Una via comune all'identificazione adulta
Vuole contatti scritti, routine, calma	Comunicazione a canale singolo; la prevedibilità riduce il carico

Provate questo

- **Offrite l'AHAT di AASPIRE** e opzioni **scritte in primo luogo**; permettete un partner o accompagnatore alle visite.
- **Chiedete del carico sensoriale, del sonno e del recupero**, non solo dell'umore — segnalate precocemente il burnout.
- **Rendete la cura perinatale prevedibile**: stesso clinico, stanza calma, piano scritto chiaro; spiegate ogni passo.
- **Screenate proattivamente i bisogni del genitore** — sottostimeranno; chiedete di dolore, esaurimento, alimentazione.
- **Protegete i suoi interessi e le sue routine** come risorse di benessere, e co-create un ritmo familiare sostenibile.

Evitate questo

- Interpretare il sovraccarico sensoriale o lo shutdown come „non si lega” al neonato, o come sola depressione.
- Aggiungere richieste imprevedibili o visite a domicilio a sorpresa senza preavviso.
- Dare per scontato che si rivolgeranno da soli quando sono in difficoltà — spesso non lo fanno.

Quando serve altro supporto

Guardatevi dal **burnout autistico** e dalla malattia mentale perinatale (le due possono sovrapporsi ed entrambe richiedono cure specifiche). Segnalate il **supporto tra pari di genitori autistici** e l'aiuto pratico (pause, pasti, sonno). Affrontate le condizioni co-occorrenti **ADHD, ansia, sonno e gastrointestinali**. Dove la famiglia include un bambino neurodivergente, coordinatevi con i servizi pediatrici e riconoscete il carico cumulativo.

Se il genitore è una madre

Le madri autistiche sono spesso mal-diagnosticate (ansia/depressione perinatale) e mascherano intensamente, anche con i clinici. Chiedete di differenze sociali/sensoriali di tutta la vita, non solo dell'umore attuale.

Informazioni su questa guida

Con assistenza IA, derivata dalle bozze di ricerca del progetto — la sintesi sul **Monotropismo**, la guida per la **famiglia** (Parte 4) e la guida **Lifespan per professionisti e sanitari** (Parti 3.4 e 4). Usa il linguaggio con l'identità per prima. **Informativa — non è consiglio medico né strumento diagnostico**. Adattatela al/dalla singolo/a.

Fonti chiave. Murray, Lesser & Lawson (2005); Murray, F. (2023); Dwyer (2025); Raymaker et al. (2020); Pearson & Rose (2021); Kelly Mahler (2024, interocezione); AASPIRE AHAT. Le citazioni complete sono nelle bozze di fonte.